

Ruminasyon Sendromu

Öğün sırasında/sonrasında ortaya çıkan efortsuz, öğürtüsüz regürjitasyonun tanısı; birinci basamak diyafragmatik solunum tedavisi ve GÖRH/gastroparezi ayrımı için pratik karar yolu.

Rome IV

Diyafragmatik Solunum

HRIM

Ayırıcı Tanı

01 Tanım ve İlk Değerlendirme

Ruminasyon sendromu; yeni yutulan gıdanın öğün sırasında veya kısa süre sonra, öğürtü (retching) veya öncü bulantı olmaksızın, efortsuz biçimde ağza geri gelmesi ve ardından yeniden çiğnenip yutulması ya da tükürülmesidir. Tanı esas olarak Rome IV klinik ölçütlerine dayanır; öykü ve muayene çoğu olguda yeterlidir.

Efortsuz regürjitasyon

Öğürtü YOK

Öncü bulantı YOK

Uykuda görülmez

Postprandiyal başlar

Yönlendirici Öykü

- Semptomların öğünle ilişkisi: ilk 10-15 dk içinde, gıda henüz asidik değilken başlar, gıda asitlendikçe (yaklaşık 20-30 dk) azalır.
- Regürjite materyalin tadı acı/ekşi değil, taze gıda tadındadır; içerik yeniden çiğnenip yutulur veya tükürülür.
- Öğürme, kusma çabası, kas gerginliği, karın ağrısı öncülü YOKtur; bilinçli olarak baskılanabilir.
- Tetikleyici/öncül olay: geçirilmiş viral gastroenterit, GÖRH, cerrahi, psikososyal stres, okul kaygısı.
- Komorbidite taraması: anksiyete/depresyon, yeme bozukluğu, nörogelişimsel bozukluk, fibromiyalji/fonksiyonel bozukluklar.
- Süre: tanıdan önce en az 2 aydır mevcut (adölesan Rome IV H1c).

Muayene ve İlk Gözlem

- Antropometri: kilo/boy persentili, büyüme eğrisi; kilo kaybı/duraklaması alarm bulgusudur.
- Postprandiyal gözlem: kliniğe öğün sonrası ruminasyon epizodunun doğrudan izlenmesi tanısal değere sahiptir (sıklıkla karın duvarında hafif kasılma öncüsü).
- Diş erozyonu, halitozis, ağız içi asit hasarı; dehidratasyon bulguları.
- Karın muayenesi tipik olarak normaldir; distansiyon, kitle, organomegali organik zemini düşündürür.
- Nörolojik muayene ve gelişimsel değerlendirme (özellikle infant ve nörolojik bozukluklu çocukta).
- Alarm bulgusu taraması (bkz. Bölüm 05) her değerlendirmede zorunludur.

Rome IV özeti: Adölesanda (H1c) tekrarlayan regürjitasyon ile yeniden çiğneme/yutma-tükürme; öğün sonrası kısa sürede başlar, uykuda olmaz, öğürtü ile öncülenmez ve uygun değerlendirmeye başka bir

hastalıkla tam açıklanamaz; tanıdan önce en az 2 aydır mevcut olmalıdır. İnfant ruminasyonu (G2) için en az 2 ay süren, karın-diyafram-dil ko-kontraksiyonu ve GÖRH tedavisine yanıtızlık gerekir.

02 Mekanizma ve Patofizyoloji

Ruminasyon, öğrenilmiş/istemsiz bir karın duvarı ve diyafram ko-kontraksiyonunun postprandiya intrağastrik basınç artırarak alt özofageal sfinkter (AÖS) bariyerini aşması sonucu gastrik içeriğin retrograd hareketiyle oluşur. Tedavi hedefi bu döngüyü diyafragmatik solunumla kırmaktır.

Postprandiya Intrağastrik Basınç Artışı

- İstemsiz karın duvarı kontraksiyonu ile intrağastrik basınç >25-30 mmHg'ye çıkar.
- HRIM'de retrograd akıştan hemen önce görülen tetikleyici bulgu.

AÖS Bariyer Yetersizliği

- Geçici AÖS gevşemesi (tLESR) veya basınç gradyanıyla bariyerin aşılması.
- Baklofenin etki hedefi: tLESR sıklığını azaltmak.

Karın-Diyafram Ko-kontraksiyonu

- Alışkanlık haline gelmiş, sıklıkla farkında olunmayan istemsiz kas paterni.
- Diyafragmatik solunum bu paterni fizyolojik olarak inhibe eder.

Öncül/Tetikleyici Olay

- Geçirilmiş GÖRH, viral gastroenterit, cerrahi, ağrılı GİS olayı.
- Psikososyal stres, okul kaygısı, travmatik yaşantı.

Operant Pekiştirme

- Regürjitasyon geçici rahatlama sağlayarak davranışı pekiştirir.
- Kronikleşme ve öğrenilmiş refleks döngüsü.

Komorbid/Kolaylaştırıcı Faktörler

- Anksiyete, depresyon, yeme bozukluğu, fonksiyonel karın ağrısı.
- Nörogelişimsel bozukluk (infant ve ağır engelli çocukta insidans artışı).

03 Karar Akışı

Klinik tanıyı Rome IV ile koy; alarm/atipik bulgu varsa organik zemini dışla, yoksa doğrudan diyafragmatik solunum tedavisine başla ve yanıtı göre basamaklandır.

BAŞLANGIÇ

Postprandiyal effortsuz regürjitasyon

Öğün sırasında/sonrasında öğürtüsüz, öncü bulantısız, uykuda olmayan geri gelme öyküsü.

ADIM 1

Öykü + Rome IV + alarm taraması

Rome IV ölçütlerini uygula; postprandiyal klinik gözlem yap; kilo, büyüme ve alarm bulgularını tara.

KARAR 1

Alarm bulgusu ya da atipik özellik var mı?

Kilo kaybı, disfaji, uykuda semptom, gerçek kusma/öğürtü, hematemez, gece ağrısı, anemi.

EVET → Organik zemini dışla

HAYIR → Klinik tanı

ALARM YOLU

Yapısal/motilite tetkiki

Üst GİS endoskopi + biyopsi, postprandiyal HRIM-impedans, gastrik boşalma sintigrafisi; GÖRH/gastroparezi/akalazya/eozinofilik özofajit ekarte edilir.

TANI

Rome IV ile ruminasyon sendromu

İnvaziv tetkik gerekmez; tanısal şüphe sürerse postprandiyal HRIM ile doğrula (retrograd akış öncesi gastrik basınç artışı).

ADIM 2

Diyafragmatik solunum eğitimi

Birinci basamak davranışsal tedavi: öğünlerde ve regürjitasyon hissedildiğinde yavaş diyafragmatik (abdominal) solunum ile ko-kontraksiyonu inhibe et.

KARAR 2

4-6 haftada anlamlı yanıt var mı?

Epizod sıklığı, kilo trendi ve yaşam kalitesinde düzelme değerlendirilir.

HAYIR → Basamak yükselt

EVET → İdame

REFRAKTER

Biofeedback + baklofen

HRIM/EMG destekli biofeedback ile diyafragmatik solunumu pekiştir; dirençli olguda baklofen ekle, BDT/psikoterapi ve komorbiditeyi tedavi et.

İDAME

Pekiştirme ve izlem

Diyafragmatik solunumu günlük rutine yerleştir; tetikleyicileri yönet, nüksü izlemek için periyodik takip planla.

Tanı klinik olduğu için tetkik seçici uygulanır; ileri incelemeler öncelikle alarm/atipik bulgu varlığında veya ayırıcı tanı gerektiğinde yapılır.

Ruminasyon sendromunda basamaklı değerlendirme		
BASAMAK	İÇERİK / ENDİKASYON	NOT
Basamak 1 — Klinik tanı	Rome IV ölçütleri + postprandiya klinik gözlem	Alarm yoksa çoğu olguda tek başına yeterlidir.
Basamak 2 — Bazal laboratuvar	Tam kan, CRP/ESR, elektrolit, albümin, çölyak serolojisi (anti-tTG IgA + total IgA)	Kilo kaybı, malnütrisyon veya atipik seyirde; anemi/inflamasyon organik zemini düşündürür.
Basamak 3 — Üst GİS endoskopi + biyopsi	Alarm bulgusu, disfaji, kilo kaybı, refrakter seyir	Özofajit, eozinofilik özofajit, striktür, peptik hastalık ve mukozal patolojiyi dışlar.
Basamak 4 — HRIM-impedans (postprandiya)	Standart öğün sonrası provokasyonla yüksek çözünürlüklü manometri-impedans	Doğrulayıcı altın standart: retrograd akış öncesi intragastrik basınç artışı (R dalgası, >25-30 mmHg); supragastrik geçirme ve akalazyayı ayırır.
Basamak 5 — Gastrik boşalma sintigrafisi	Gastroparezi kliniği (erken doyma, şişkinlik, gerçek kusma) varlığında	Gecikmiş boşalma gastroparezi lehine; ruminasyonda boşalma tipik olarak normaldir.

BASAMAK	İÇERİK / ENDİKASYON	NOT
Basamak 6 — 24 saat pH-impedans	GÖRH ile örtüşen/ayrım gereken olgular	Asit maruziyeti ve reflü- septom ilişkisini niceler; ruminasyonda postprandiyal nonasidik retrograd bolus paterni görülür.

Pratik nokta: HRIM postprandiyal provokasyon, ruminasyonu GÖRH, supragastrik geçirme ve akalazyadan ayıran en özgül testtir; tanısal ikilem sürüyorsa invaziv tarama yerine önce bunu düşünün.

05 Kırmızı Bayraklar

Aşağıdaki bulgulardan herhangi biri, klinik ruminasyon tanısını sorgulatır ve organik zemin için ileri değerlendirme (endoskopi/HRIM/sintigrafi) gerektirir.

● Kilo kaybı, büyüme duraklaması veya belirgin malnütrisyon

● Disfaji veya odinofaji

● Uyku sırasında regürjitasyon/septom

● Gerçek kusma veya öğürtü (retching) ile öncülenme

● Hematemez, melena veya gizli kan pozitifliği

● Sürekli veya gece uyandıran karın ağrısı

● Demir eksikliği anemisi veya inflamasyon belirteçlerinde yükseklik

● Nörolojik bulgu, letarji veya akut/subakut başlangıç

● Safralı/fışkırır tarzda kusma (obstrüksiyon şüphesi)

Dikkat: Öğürtü ile öncülenen, safralı veya gece görülen kusma ruminasyonla uyumlu DEĞİLDİR; bu olgularda GÖRH komplikasyonu, gastroparezi, obstrüksiyon veya siklik kusma sendromu öncelikli düşünülmelidir.

Temel tedavi davranışsaldır: diyafragmatik solunum ruminasyona rakip yanıt oluşturarak karın-diyafram ko-kontraksiyonunu engeller. Refrakter olguda baklofen ve biofeedback eklenir; ilaçlar komorbid GÖRH/anksiyeteye yöneliktir. Dozlar mg/kg ve maksimumla verilmiştir.

Ruminasyon sendromunda basamaklı tedavi ve dozlar	
TEDAVİ / İLAÇ	DOZ / UYGULAMA
Diyafragmatik solunum (1. basamak)	Her öğünden sonra ve epizod hissinde 10-15 dk; günde 3-4
Biofeedback / habit reversal	HRIM veya yüzeyel EMG eşliğinde, haftalık seanslar
Baklofen (refrakter olgu)	Başlangıç 0,5 mg/kg/gün, 3 doza bölünmüş; titre ile artış (ad
Omeprazol (komorbid GÖRH)	1 mg/kg/gün, tek/iki doz; maks 20-40 mg/gün
Psikoterapi / BDT	Yapılandırılmış seanslar; komorbidite şiddetine göre

TEDAVİ / İLAÇ	DOZ / UYGULAMA
Beslenme desteęi	Diyetisyen izlemi; ağır kayıpta enteral destek

İlaç seçimi: Ruminasyonun birincil tedavisi ilaç deęil, diyafragmatik solunumdur. Baklofen yalnızca davranışsal tedaviye dirençli olguda, PPI ise yalnızca kanıtlanmış komorbid GÖRH varlığında eklenmelidir; ampirik uzun süreli PPI/prokinetik kullanımından kaçının.

İzlem; epizod sıklığı, büyüme/kilo trendi, komorbidite kontrolü ve nüks açısından planlanır. Aile ve okul eğitimi tedavi başarısının belirleyicisidir.

İzlem Parametreleri

- 4-6 haftada ilk yanıt değerlendirmesi; ardından 3 ayda bir izlem.
- Semptom günlüğü: epizod sayısı, öğünle ilişki, tetikleyiciler.
- Büyüme eğrisi ve kilo trendi; malnütrisyon riskinde daha sık.
- Diş/oral sağlık ve dehidratasyon açısından periyodik değerlendirme.
- Baklofen kullanımında sedasyon, yan etki ve doz uyumu takibi.

Yönetim İlkeleri

- Diyafragmatik solunumu günlük rutine yerleştir; öğün sonrası uygulamayı önceliklendir.
- Aileyi ruminasyonun istemsiz/öğrenilmiş bir refleks olduğu konusunda eğit; suçlayıcı yaklaşımdan kaçın.
- Komorbid anksiyete/yeme bozukluğunu eş zamanlı tedavi et.
- Gereksiz tekrarlayan invaziv tetkik ve ampirik ilaçtan kaçın.
- Refrakter/malnütrisyonlu olguda multidisipliner (GE, beslenme, psikoloji) yönetim.
- Yanıt yoksa tanıyı yeniden gözden geçir; HRIM ile doğrula ve ayırıcıyı (gastroparezi/GÖRH) yeniden değerlendir.

Kaynaklar

1. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, ve ark. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.
2. Benninga MA, Faure C, Hyman PE, ve ark. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler (Rome IV, İnfant ruminasyonu G2). Gastroenterology. 2016;150(6):1443-1455.
3. Murray HB, Juarascio AS, Di Lorenzo C, ve ark. Diagnosis and Treatment of Rumination Syndrome: A Critical Review. Am J Gastroenterol. 2019;114(4):562-578.
4. Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, ve ark. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: NASPGHAN-ESPGHAN Joint Recommendations. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(3):516-554.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanlarına yönelik bir klinik karar destek aracıdır; bireysel hasta değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve klinik yargının yerini almaz. Doz ve tedavi kararları hastanın yaşı, kilosu, komorbiditeleri ve yerel onaylar doğrultusunda teyit edilmelidir.